

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE VALORES (VALUING QUESTIONNAIRE - VQ)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de Progreso y Obstrucción en Valores en Terapia ACT

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Valores (Valuing Questionnaire - VQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Valuing Questionnaire (VQ)</i>
Autores Originales	Drs. Matthew Smout, M. Davies, M. Bobrovcf et al. (2014), University of South Australia.
Adaptación Española	Francisco J. Ruiz, J. C. Suárez-Falcón, M. A. Segura-Vargas y B. Gil-Luciano (2022).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Dominio de Valores.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 10 reactivos con escala Likert de 7 puntos (0 a 6).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde los 14 años). Ámbito clínico ambulatorio, hospitalario y comunitario.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos en autoadministración; 4 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico de acceso abierto para fines clínicos y académicos no comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE VALORES EN ACT

El Valuing Questionnaire (VQ) fue concebido para medir con alta resolución clinimétrica el componente axiológico del modelo Hexaflex de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). En el marco conceptual contextual, los valores no se conciben como metas terminales estáticas ni imperativos morales introyectados, sino como direcciones vitales elegidas libremente y reforzadas intrínsecamente, que definen cualidades globales de la acción continuada en el tiempo.

Neurobiológicamente, el comportamiento guiado por valores involucra la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC) y los bucles estriatales corticolímbicos que codifican la recompensa a largo plazo frente al alivio hedónico inmediato mediado por la evitación. El VQ separa de forma pionera dos procesos independientes: el avance activo hacia lo valioso (**Progreso**) y el bloqueo generado por la lucha contra eventos privados aversivos (**Obstrucción**), permitiendo determinar si la anhedonia responde a falta de metas significativas o a una parálisis por evitación experiencial.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala de Valores	Ítems	Rango Dir.	Operacionalización Clínica y Conductual
1. Progreso en Valores (VQ-P)	1 al 5 (5 ítems)	0 a 30	Persistencia en acciones valiosas, coherencia con principios elegidos, satisfacción con el camino vital y sentido de dirección.
2. Obstrucción en Valores (VQ-O)	6 al 10 (5 ítems)	0 a 30	Interrupción de metas vitales por miedo a emociones dolorosas, postergación conductual e hiperfoco en el sufrimiento.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en validaciones hispanas: alfa de Cronbach de 0.86 a 0.89 para Progreso y de 0.84 a 0.88 para Obstrucción; coeficientes omega de McDonald > 0.87 (Ruiz et al., 2022).
Estructura Factorial	El AFC confirma el modelo bifactorial de dos dimensiones correlacionadas de manera inversa moderada ($r = -0.45$), demostrando que progreso y obstrucción no son polos opuestos sino procesos paralelos.
Validez Concurrente	Progreso correlaciona positivamente con bienestar psicológico (WHO-5, $r = 0.64$) y satisfacción vital (SWLS, $r = 0.58$). Obstrucción correlaciona fuertemente con depresión (PHQ-9, $r = 0.60$) e inflexibilidad (AAQ-II, $r = 0.68$).
Sensibilidad al Cambio	Excepcional sensibilidad a la clarificación de valores y acciones comprometidas en ACT; captura incrementos en Progreso y caídas en Obstrucción en intervenciones breves de 4 a 8 sesiones.
Invarianza de Medida	Invarianza comprobada a través del sexo, edad y niveles educativos en muestras clínicas y comunitarias.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 10 ítems se responde considerando cómo ha actuado la persona durante la **última semana** en escala de 0 a 6 (**0** = «Para nada verdad», **3** = «Frecuentemente verdad», **6** = «Completamente verdad»):

- **Puntuación de Progreso en Valores (VQ-P):** Suma de los ítems **1 + 2 + 3 + 4 + 5** (Rango: **0 a 30 puntos**).
- **Puntuación de Obstrucción en Valores (VQ-O):** Suma de los ítems **6 + 7 + 8 + 9 + 10** (Rango: **0 a 30 puntos**).
- **Regla Esencial:** No debe calcularse una puntuación total agregada sumando los 10 ítems. Progreso y Obstrucción representan coordenadas independientes que perfilan la eficacia y las barreras vitales del paciente.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS DE REFERENCIA

Nivel Clínico	VQ-P (Progreso)	VQ-O (Obstruc.)	Significación Clínica y Perfil de Acción
Bajo	0 a 14 puntos	0 a 9 puntos	En VQ-P: Desvitalización severa y vacío existencial. En VQ-O: Mínima interferencia del malestar en metas vitales (perfil adaptativo).
Moderado	15 a 22 puntos	10 a 17 puntos	Nivel intermedio funcional. Avance discontinuo en valores con vulnerabilidad a bloqueos temporales ante estresores.
Alto	23 a 30 puntos	18 a 30 puntos	En VQ-P: Vida plenamente congruente y significativa. En VQ-O (>= 18): Bloqueo severo en valores; parálisis por evitación experiencial.

EL PERFIL DE MÁXIMA DESCONEXIÓN EXISTENCIAL:

La combinación de **Bajo Progreso (VQ-P < 15)** con **Alta Obstrucción (VQ-O >= 18)** es el indicador patognomónico de desesperanza clínica en trastornos afectivos y dolor crónico. El sujeto no solo ha abandonado sus propósitos vitales, sino que dedica el 100% de su energía diaria a luchar contra sus propios pensamientos y emociones.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN PROCESOS DE VALORES ACT

GUÍA DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL CUADRANTE DEL VQ:

- **Cuadrante 1: Bajo Progreso + Alta Obstrucción (Parálisis Evitativa):** Intervención urgente en aceptación y defusión. El paciente intenta controlar el dolor antes de vivir. Desmantelar la agenda de control ("cuando se me pase la tristeza empezaré a vivir") e introducir micro-acciones comprometidas con el malestar a cuestas.
- **Cuadrante 2: Bajo Progreso + Baja Obstrucción (Deriva o Desconexión Axiológica):** El paciente no sufre una lucha interna intensa, sino una falta de dirección. Foco en clarificación de valores (ejercicios del epitafio y brújula vital).
- **Cuadrante 3: Alto Progreso + Alta Obstrucción (Héroe Agotado):** Avanza en metas pero con un sufrimiento y resistencia extenuantes. Entrenar autocompasión y flexibilidad en estándares personales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN Y ABANDONO VITAL

Paciente: Mujer de 28 años, licenciada en bellas artes, acude a consulta tras dos años recluida en el hogar familiar sin buscar empleo ni pintar. Refiere: «No puedo coger los pinceles porque siento una angustia terrible en el pecho y pienso que no valgo nada».

Evaluación Basal VQ:

- **Progreso en Valores (VQ-P): 4 / 30 puntos** (Bajo extremo; ítem 1 = 1, ítem 3 = 0: desconexión total con lo que le importa).
- **Obstrucción en Valores (VQ-O): 26 / 30 puntos** (Severo extremo; ítem 6 = 6, ítem 8 = 5, ítem 10 = 5: parálisis absoluta por evitación).

Formulación Clínica: La paciente está atrapada en una regla verbal de coherencia: "Para pintar tengo que sentirme inspirada y segura". Al aparecer la duda y la angustia, interrumpe la conducta, produciendo atrofia artística y depresión reactiva secundaria.

Tratamiento ACT y Evolución: En 10 sesiones se practicó exposición con prevención de respuesta experiencial: pintar durante 20 minutos diarios experimentando conscientemente la angustia somática en el pecho (defusión y disposición). A los 3 meses: VQ-P subió a **22 puntos** y VQ-O descendió a **8 puntos**, finalizando una serie pictórica y presentando su portafolio profesional.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE PROCESOS

OBSTRUCCIÓN EXTREMA Y RIESGO DE DESESPERANZA

Puntuaciones de VQ-O ≥ 25 asociadas a VQ-P < 5 señalan una pérdida total del sentido vital que frecuentemente precede a la ideación suicida pasiva. Explorar inmediatamente razones para vivir e iniciar acompañamiento vincular.

CONFUSIÓN ENTRE VALORES Y MANDATOS EXTERNOS

Si un paciente puntúa alto en Progreso pero relata cansancio extremo y vacío, indagar si los "valores" perseguidos son intrínsecos o meras expectativas parentales o sociales introyectadas (pliant tracking).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Smout, M., Davies, M., Bobrovic, M., et al. (2014). The Valuing Questionnaire (VQ): Development and psychometric properties. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 3(3), 164–172.
2. Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Segura-Vargas, M. A., & Gil-Luciano, B. (2022). Psychometric properties of the Valuing Questionnaire in Colombia. *Journal of Clinical Psychology*, 78(2), 233–248.
3. Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. *The Psychological Record*, 60(2), 249–272.
4. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.). Guilford Press.